

FALA DE APRESENTAÇÃO DO BANNER

Manejo odontológico do paciente com TEA nível 3, TDAH e TAG

Simpósio de Pacientes com Necessidades Especiais

VERSÃO COMPLETA — cerca de 5 minutos

As marcações entre colchetes são só para você, não fazem parte da fala.

[ABERTURA — 20 segundos. Olhe para a pessoa, não para o banner.]

Bom dia! Meu nome é Thamyres Tosarelli, esse trabalho eu fiz junto com a Beatriz Gouvea, com orientação dos professores Rosemary Baptista Martins Teixeira e Ricardo Matsura Kodama. O nosso tema é o manejo odontológico do paciente com Transtorno do Espectro Autista nível 3, associado a TDAH e a Transtorno de Ansiedade Generalizada. Posso começar?

[POR QUE ESSE TEMA — 30 segundos. Aponte a foto da paciente.]

A gente escolheu esse tema por causa de uma paciente que a gente atende aqui na clínica de pacientes com necessidades especiais. Ela tem oito anos e tem esses três diagnósticos juntos. É uma paciente pouco colaborativa, e a partir da dificuldade que a gente encontrou no atendimento dela a gente foi buscar na literatura o que é recomendado para esse perfil.

[O QUE É CADA CONDIÇÃO — 1 minuto. Aponte o quadro das condições.]

O autismo é classificado em três níveis, de acordo com o quanto a pessoa precisa de apoio. O nível 3 é o mais grave, é o que a literatura chama de apoio muito substancial: a comunicação verbal é bem limitada, existem comportamentos repetitivos e, o que mais importa para a gente na odontologia, existe uma alteração no processamento sensorial. Ou seja, luz, ruído, cheiro e toque são sentidos de um jeito muito mais intenso do que a gente sente.

Junto com isso, essa paciente tem TDAH, que traz desatenção e impulsividade, então ela não consegue se manter parada na cadeira por muito tempo. E tem o transtorno de ansiedade generalizada, que faz com que ela já chegue no consultório em estado de alerta, antecipando que alguma coisa ruim vai acontecer. Quando essas três condições se somam, a colaboração cai muito.

[POR QUE ISSO IMPORTA NA ODONTOLOGIA — 45 segundos. Aponte a parte do risco de cárie.]

E isso tem consequência direta na saúde bucal. Esses pacientes têm mais cárie e mais doença periodontal, e não é pela condição em si. É pela soma de quatro coisas: a higiene depende do cuidador, então nem sempre é feita do jeito ideal; a dieta costuma ser seletiva, muitas vezes pastosa e açucarada, porque a criança recusa textura; a hipersensibilidade na boca faz a criança não aceitar a escova; e os medicamentos que ela usa, como metilfenidato e risperidona, reduzem o fluxo salivar. Uma metanálise de 2022 mostrou que crianças com TDAH têm mais de três vezes mais chance de ter cárie do que crianças sem o transtorno.

[O MIOLO: COMO FAZER O CONDICIONAMENTO — 1 minuto e 30. Vá acompanhando com a mão.]

Aí vem a pergunta principal do trabalho: como deixar esse paciente mais colaborativo? A literatura mostra que isso se constrói, não acontece de uma vez.

Primeiro, a anamnese tem que ser mais detalhada do que a habitual. A gente precisa perguntar ao responsável qual é a rotina da criança, como ela se comunica, se ela usa alguma prancha ou aplicativo, e quais são os estímulos que incomodam. Isso muda completamente a forma de conduzir a consulta.

Segundo, previsibilidade. As consultas devem ser curtas, sempre no mesmo horário, na mesma sala e com a mesma equipe. Para essa criança, mudar a sala ou o operador já é motivo de recusa. E a primeira consulta deve ser só de adaptação, sem nenhum procedimento. Parece perda de tempo, mas é o que faz a segunda consulta acontecer.

Terceiro, o condicionamento propriamente dito, que é gradual. A gente usa a dessensibilização, apresentando o consultório aos poucos, junto com o dizer-mostrar-fazer, com pranchas e agendas de figuras que mostram a sequência do que vai acontecer, com vídeos que a criança assiste em casa antes de vir, e com reforço positivo a cada etapa que ela consegue cumprir. A metanálise que a gente cita mostrou que a pedagogia visual melhora tanto a cooperação quanto a qualidade da escovação.

E quarto, o ambiente. Diminuir a luz, o barulho e o cheiro, e deixar o cuidador junto. Um ensaio clínico de 2023, com 162 crianças autistas, mostrou que só adaptar o ambiente já reduz o estresse fisiológico da criança, medido no corpo dela, em todas as fases da consulta.

[QUANDO ESCALAR — 30 segundos.]

Agora, isso não funciona com todo mundo. Quando o manejo básico não é suficiente, aí sim entram a contenção protetora, a sedação e a anestesia geral. Mas a diretriz da Academia Americana de Odontopediatria é clara: isso é manejo avançado, vem depois, com consentimento informado e registro em prontuário, e sempre na técnica menos restritiva possível.

[FECHAMENTO — 30 segundos. Volte a olhar para a pessoa.]

Para concluir: a nossa principal conclusão é que não existe um protocolo único. O autismo é muito heterogêneo e os próprios estudos reconhecem essa limitação. O que funciona é individualizar, construir junto com a família e insistir na prevenção, porque quanto mais a gente previne, menos a gente precisa recorrer à anestesia geral. Obrigada!

VERSÃO CURTA — cerca de 2 minutos

Para quando a pessoa disser "me resume rapidinho" ou quando a fila estiver grande.

Bom dia! Eu sou a Thamyres, esse trabalho é meu e da Beatriz, orientado pela professora Rosemary Baptista Martins Teixeira e pelo professor Ricardo Matsura Kodama. A gente fez uma revisão de literatura sobre o manejo do paciente com autismo nível 3 associado a TDAH e ansiedade generalizada, a partir de uma paciente de oito anos que a gente atende na clínica.

O ponto central é que esse paciente tem mais cárie e mais doença periodontal, mas não por causa do transtorno em si: é a higiene que depende do cuidador, a dieta seletiva, a hipersensibilidade na boca e a boca seca causada pela medicação.

E a literatura mostra que a colaboração é construída. Anamnese detalhada com o responsável, consultas curtas e previsíveis, sempre no mesmo horário e com a mesma equipe, primeira consulta só de adaptação, e o condicionamento gradual com dessensibilização, dizer-mostrar-fazer, pranchas de figuras, vídeo antes da consulta e reforço positivo. Adaptar o ambiente, diminuindo luz e ruído, reduz o estresse fisiológico da criança.

Contenção, sedação e anestesia geral só quando isso tudo não basta. E a conclusão é que não existe protocolo único: tem que individualizar e apostar na prevenção. Obrigada!

SE TRAVAR OU ESQUECER

- Se esquecer a sequência, use o banner como roteiro: leia o título do tópico e desenvolva a partir dele. Ninguém percebe.
- Se esquecer um número, não invente. Diga "a metanálise mostrou um risco significativamente maior" e siga.
- Se te interromperem no meio, responda a pergunta e depois retome com "voltando ao que eu estava falando...".
- Se perguntarem algo que você não sabe, diga que não sabe, mas diga o que sabe perto disso. "Esse dado específico eu não tenho, mas o que eu vi na literatura foi..."

DICAS DE POSTURA

- Não leia o banner. Quem avalia já sabe ler. Você está ali para contar o que o banner não diz.
- Fique ao lado do banner, nunca na frente. Aponte com a mão aberta, não com o dedo.
- Fale com quem está perguntando, não com o painel.
- Comece perguntando "posso começar?" ou "quanto tempo eu tenho?". Mostra segurança e evita você ser cortada no meio.
- Se tiver foto da paciente no banner, comece por ela. Caso real prende a atenção mais do que qualquer introdução teórica.
- Treine em voz alta pelo menos três vezes, cronometrando. Ler mentalmente engana, você sempre demora mais falando.

OBSERVAÇÃO SOBRE UM DADO DA FALA

Na versão completa há a possibilidade de citar que a modelagem por vídeo reduz o número de consultas necessárias, que vem de um ensaio clínico brasileiro (DA SILVA MORO et al., Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 54, n. 2, p. 501-508, 2024). Esse estudo não está na lista de referências do resumo de TEA. Se quiser usar esse dado na apresentação, acrescente a referência na lista, para não citar na fala um trabalho que não aparece no banner.